

Scouts du Sénégal
Région de Dakar
Groupe XII[e] Dakar
Paroisse NDA Ouakam

Secourisme

Vle Dakar

PLAN

I/ Définition

II/ Les 3 temps du secourisme

1- Protéger
2- Alerter
3- Secourir
   a) Examen d'une victime
   b) Gestes d'urgences
   c) Surveillance

III/ Les 10 règles du secouriste

IV/ Boîte à pharmacie

V/ Quelques notions

I/ Définition

Le secourisme est un ensemble de moyens techniques que l'on met en pratique permettant ainsi d'effectuer les premiers gestes d'urgence pour soulager une (des) victime(s) avant l'arrivée des secours.

II/ Les 3 temps du secourisme

En cas d'accident, il faut :

1- Protéger

♣ **Definition**

La protection vise à prévenir un sur danger. On protège soi même, la (les) victime(s), les tiers. La protection doit être immédiate, adaptée, suivant les circonstances mais également permanente.

Pour réaliser la protection, utiliser tous les moyens matériels dont on peut disposer et s'assurer si besoin du concours de toute personne apte qui pourrait apporter une aide dans la mise en œuvre de cette protection

♣ **Dégagement d'urgence de la victime de la zone dangereuse en toute sécurité**

Devant l'impossibilité de supprimer le danger et si la victime est incapable de se soustraire elle-même au danger, dégager la victime le plus rapidement possible. Le sauveteur doit pour ce dégagement, respecter les principes suivants:

- Choisir la technique de dégagement en tenant compte de sa force physique;
- Saisir solidement la victime par exemple par les poignets ou les chevilles et la tirer sur le sol quelle que soit sa position, jusqu'à ce quelle soit en lieu sûr;
- Se faire aider éventuellement par une autre personne.

Le dégagement d'urgence est une manœuvre éventuelle qui ne doit être utilisée que pour soustraire une victime à un danger vital, réel, immédiat et non contrôlable. Cette manœuvre peut être dangereuse pour une victime atteinte d'un traumatisme.

TECHNQUES

- traction par les chevilles
- saisie par les poignets
- dégagement d'un véhicule
- dégagement en relais : elle est réalisée lorsque la victime n'est pas visible en totalité (sous un véhicule, …). Il y a 4 façons pour dégager la victime en relais :

Xlle Dakar

- par les aisselles
- par un poignet et la ceinture
- par les poignets
- par les chevilles : dans le cas ou la tête n'est pas accessible.

- ramassages ou relevages : à effectuer que si la victime ne présente pas de traumatisme.
  -relevage en « cuiller »
  -le coup du pompier
  -relevage en position demi assise
  - brancard : en cas de traumatisme subit, le brancard peut être utilisé ; et la victime doit être bien immobilisée.

IMPORTANT :
- en cas d'accident, il faut baliser la zone à 200m ou 30m en amont et en aval. En cas d'immobilisation du véhicule dans un virage, le triangle doit être positionné avant le virage, pour que les autres véhicules soient prévenus. (C'est la protection).
- pour procéder à un dégagement d'urgence, il faut respecter l'axe « tête-cou-tronc ».

2- Alerter

L'alerte est l'action qui consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses ainsi que la situation générale des faits. Dans ce contexte, l'absence d'information d'un service d'urgence peut compromettre la vie ou la santé d'une victime malgré les premiers secours assurés par un sauveteur.
En ville, alerter : les Sapeurs Pompiers (18), ou le SAMU (1515) et la Police (17).
En campagne : Sapeurs Pompiers ou le Samu et la Gendarmerie (800 00 20 20).

COMMENT ALERTER
Il faut s'exprimer avec clarté et précision. L'appelant doit pouvoir donner les indications suivantes:

- Son nom et numéro de téléphone;
- Localisation très précise de l'événement ;
- Nature du problème ;
- Nombre de victimes et état apparent de chaque victime ;
- Risques éventuels ;
- Premières mesures prises et gestes effectués.

NB: Ne pas raccrocher sans autorisation.

XIIe Dakar

3- <u>Secourir</u>

Le secours est le geste élémentaire de survie qui peut sauver. Secourir c'est porter secours à quelqu'un, le sauver d'un danger.

<u>A) Examen de la victime</u>

C'est le coup d'œil, le geste qui sauve, il doit se faire rapidement. Il permet de savoir l'état de la victime :

- ♣ <u>Si la victime s'étouffe</u> ➔ le mouvement de l'air entre l'extérieur et les poumons est complètement empêché du fait d'une obstruction totale des voies aériennes.
  <u>Signes</u> : brutalement la victime :
  -porte la main à sa gorge ;
  -ne peut plus parler ;
  -garde la bouche ouverte ;
  -fait des efforts pour respirer sans que l'air n'entre ni ne sorte ;
  -ne peut plus tousser.
- ♣ <u>Si la victime saigne</u> ➔ une hémorragie est l'écoulement du sang hors de son circuit normal et causé par la rupture d'un vaisseau sanguin.
  Hémorragie externe=> C'est lorsque l'écoulement se produit à l'extérieur du corps.
  Hémorragie interne=> C'est lorsque l'écoulement se produit à l'intérieur du corps. (Signes: ventre grossi, peau moite et froide, saignement du nez ou des oreilles, soif intense, respiration anormale, perte graduelle de l'état de conscience, nausées et vomissements, etc.).
- ♣ <u>Si la victime est inconsciente</u> ➔ Une *victime inconsciente* est une personne qui a perdu toute capacité relationnelle. Elle ne répond pas aux ordres simples, ...
- ♣ <u>Si la victime ne respire plus</u> ➔ la victime ne parle pas, elle ne réagit pas à un ordre simple, aucun mouvement de la poitrine ni de l'abdomen n'est visible et aucun bruit ou souffle n'est perçu.
- ♣ <u>Si la victime se plaint d'un malaise</u> ➔ un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, sans que le sujet qui l'éprouve puisse en identifier obligatoirement l'origine. Il peut être fugace ou durable, de survenue brutale ou progressive.
- ♣ <u>Si la victime présente une plaie</u> ➔ la plaie est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec atteinte possible des tissus sous la peau.

Ville Dakar

♣ <u>Si la victime présente une brulure</u> ➔ une brulure est une lésion de la peau et éventuellement des tissus sous-jacents, provoquées par la chaleur, une substance chimique, l'électricité, un frottement, ou des radiations.

♣ <u>Si la victime présente un traumatisme des os ou des articulations</u> ➔ - une fracture est la cassure de l'os.
-Une luxation est un déboîtement de l'articulation.
-Une entorse correspond à un étirement ou à une déchirure des ligaments qui maintiennent en place une articulation.

<u>NB</u> : il faut réconforter la victime, dialoguer avec lui si possible.

<u>B) Gestes d'urgences</u>

A chaque cas, il y a une conduite à tenir (CAT) :

♣ **<u>La victime s'étouffe</u>** :

<u>CAT :</u>

1- Laisser la victime dans la position où elle se trouve (habituellement debout ou assise).
2- Constater l'obstruction totale ou partielle des voies aériennes.
3- Désobstruer les voies aériennes en lui donnant 5 claques sur le dos.
4- En cas d'inefficacité des claques sur le dos, réaliser 5 compressions abdominales selon la méthode décrite par HEIMLICH.
5- Constater l'efficacité des claques sur le dos ou des compressions abdominales (vérifier si le corps étranger est visible dans la bouche de la victime pour pouvoir l'extraire soigneusement).

Après expulsion du corps étranger, le sauveteur doit parler à la victime, la réconforter et demander un avis médical.
Si l'obstruction persiste malgré tout, réaliser à nouveau ce qui a été fait (5 claques sur le dos et 5 compressions abdominales).

♣ **<u>La victime saigne</u>**

<u>CAT :</u>

1- Arrêter l'hémorragie=> compression directe ou à distance.
2- Allonger la victime en position horizontale (avec les jambes plus élevées si c'est une hémorragie interne).
3- Donner l'alerte ou mieux faire donner l'alerte.
4- Vérifier que l'hémorragie est arrêtée et parler à la victime en attendant les secours :
   * ne pas donner à boire
   *protéger la victime contre le froid ou les intempéries
   *pendant toute la réalisation de la CAT, expliquer à la victime ce qui se passe pour la réconforter et rechercher sa coopération.

Xlle Dakar

NB : Des maladies peuvent être transmises par le sang en cas de plaie même minime des mains du sauveteur. Dans ce cas, il faut porter des gants ou glisser sa main dans un sac imperméable. Après l'action de secours se laver les mains, les désinfecter et retirer les vêtements souillés de sang le plus tôt possible.

Compression à distance

Cette compression n'est faite que lorsque :
- la compression directe sur la plaie est impossible : fracture ouverture, plaie inaccessible, ou avec un corps étranger que l'on ne doit jamais retirer (risques d'aggraver la lésion) ;
- la compression directe sur la plaie est inefficace et le sang continue de couler ;
- le sauveteur présente une plaie des mains et ne possède pas de moyens de protection.

Techniques : il faut assurer une compression du vaisseau qui est la principale source de l'hémorragie entre le cœur et la plaie qui saigne.
Le point de compression s'effectue :
-au pli de l'aine, pour les saignements du membre inférieur ;
-sur la face interne du bras pour les saignements du membre supérieur ;
-à la base du cou pour une plaie du cou qui saigne.

Le garrot

Le garrot n'est utilisé qu'en cas de force majeure :
-impossible de réaliser les compressions du fait de la position de la victime ;
-les compressions sont inefficaces et le sang continue de couler ;
-les compressions ne peuvent être maintenues par un sauveteur isolé qui doit donner l'alerte ou qui doit s'occuper d'une autre victime grave.
Le garrot est mis en place :
-au membre inférieur, sur la cuisse, entre la plaie et l'aine.
-au membre supérieur, sur le bras, entre la plaie et l'aisselle.
Il doit être réalisé avec un lien large : cravate, écharpe, foulard, jamais avec une ficelle, un fil de fer ou un garrot élastique pour éviter un cisaillement du membre.

NB : Le garrot doit toujours rester visible : ne pas le couvrir. L'heure de pose du garrot doit être relevée et toujours marquée de façon claire et visible sur la victime. Une fois posée, le garrot ne doit jamais être desserré. Seul un médecin est autorisé à l'enlever.

Xlle Dakar

Saignement du nez

CAT :

1- Laisser la victime assise, tête penchée en avant, ne pas l'allonger pour éviter qu'elle avale son sang ;
2- Demander à la victime de se moucher vigoureusement ;
3- Lui demander de comprimer avec son doigt la narine qui saigne pendant 10mn.
4- Si le saignement de nez ne s'arrête pas ou se produit encore, l'avis d'un médecin est nécessaire.

♣ **La victime ne respire plus**

CAT :

1- Placer la victime sur le dos si elle n'est pas déjà dans cette position ;
2- Appeler « à l'aide » si vous êtes seul ;
3- Vérifier l'état de conscience ;
4- Assurer immédiatement la LVA :

*desserrer ou dégager tout ce qui peut gêner la respiration (boucle de ceinture, bouton de pantalon, cravate, col), mais pas les vêtements.
*basculer doucement la tête de la victime en arrière et élever le menton
*retirer les corps étrangers visibles à l'intérieur de la bouche de la victime s'il y en a avec la main qui tenait le front ;

5- Apprécier la respiration pendant 10s au plus :

*se pencher sur la victime, l'oreille et la joue du sauveteur au dessus de Sa bouche et de son nez, son menton élevé tout en regardant si ses Poumons et son ventre s'élèvent et s'abaissent.

6- Pratiquer immédiatement deux insufflations;
7- S'assurer de la présence de signes de circulation ; si la victime ne respire toujours pas continuer les manœuvres ;
8- Débuter la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : Pratiquer les compressions thoraciques associées à une ventilation artificielle ;
9- Poursuivre les manœuvres de réanimation et surveiller leur efficacité => Tous les 5 cycles de 15 compressions thoraciques et de 2 insufflations (10 cycles de 5 compressions thoraciques et de 1 insufflation chez l'enfant et le nourrisson), le sauveteur interrompt les manœuvres de RCP pour rechercher la présence de signes de circulation. Cette recherche ne doit pas durer plus de 10 secondes.

Si les signes de circulation, dont la respiration, sont présents, installer la victime en PLS et surveiller en permanence sa respiration. Si la

Xlle Dakar

respiration s'arrête de nouveau ou en cas de doute remettre la victime sur le dos et recommencer la RCP.

Techniques de ventilation artificielle sans matériel
*le bouche-à-bouche
*le bouche-à-nez
*le bouche-à-bouche et nez.

♣ **La victime est inconsciente**

CAT :

1- Rechercher toute détresse évidente qui peut menacer la vie (saignements visibles et importants) ;
2- Apprécier l'état de conscience : secouer l'épaule de la victime. Si elle ne réagit pas elle est inconsciente ;
3- Si le sauveteur est seul, appeler à l'aide ;
4- Assurer immédiatement la LVA (si la victime ne respire pas). Même méthode que la précédente.
6- Placer la victime en position latérale de sécurité (PLS) ;
7- Contrôler la respiration de la victime en attendant les secours.

♣ **La victime se plaint d'un malaise**

CAT :

1- Observer les signes de malaise ;
2- Mettre la victime au repos et la rassurer en lui parlant sans énervement ;
3- S'enquérir de son état de santé habituel (questions à la victime ou son à son entourage) ;
4- Prendre un avis médical ;
5- Surveiller régulièrement la victime.

♣ **La victime présente une plaie**

***Plaie simple** :

CAT :

1- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ;
2-Nettoyer la plaie avec de l'eau courante avec ou sans savon
3- Protéger la plaie par un pansement adhésif ou compresse si la plaie risque d'être à nouveau souillée ;
4- Demander à la victime (si nécessaire) si elle est vaccinée contre le tétanos et si ça remonte à plus de 10ans ;
5- Si la plaie devient chaude, si elle gonfle ou si elle continue de faire mal dans les 24h, consulter un médecin.

Xlle Dakar

*__Plaie grave :__

CAT :

1- Identifier la gravité de la plaie ;

2- Installer la victime en position d'attente :

- Plaie du thorax : position demi-assise ;
- Plaie de l'abdomen : position à plat dos, cuisses fléchies, jambes horizontales.
- Plaie de l'œil : >>allonger la victime à plat dos ;
  >>lui demander de fermer ses yeux et de ne pas bouger sa tête ;
  >> ne jamais retirer un corps étranger de l'œil et de n'importe quelle plaie.

3- Demander un avis médical ;

4- Protéger la victime du froid, de la chaleur ou des intempéries ;

5- Parler régulièrement à la victime et lui expliquer ce qui se passe pour la réconforter.

♣ **La victime présente une brulure**

- Brulure simple : C'est une cloque d'une surface inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime.
- Brulure grave : Cloque unique ou multiple d'une surface supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime. Destruction plus profonde (aspect blanchâtre et noirâtre parfois indolores).

CAT :

1- Supprimer la cause ou soustraire la victime à la cause ;

2- Refroidir le plus tôt possible la surface brulée ;

3- Retirer les vêtements de la victime

4- Surveiller la victime, lui parler, ne pas percer la(les) cloque(s).

5- Alerter les secours

Brulures électriques

- Ne pas toucher la victime avant d'être sûr que tout risque électrique soit écarté ;
- Arroser la zone brulée visible, à l'eau courante (tempérée 15-25°)
- Alerter les secours et suivre les conseils donnés.

♣ **La victime présente un traumatisme des os ou des articulations**

Xlle Dakar

- Traumatisme du dos, de la tête ou de la nuque

CAT :
1- Ne jamais mobiliser la victime ;
2- Conseiller fermement au blessé de ne faire aucun mouvement en particulier de la tête ;
3-Faire alerter les secours d'urgence ;
4- Maintenir la tête avec les 2 mains placées de chaque côté de celle-ci, le sauveteur est à genoux derrière le blessé ;
5- Surveiller la victime de manière continue, lui parler.

- Traumatisme de membres

CAT :
1- Interdire toute mobilisation du membre atteint ;
2- Immobiliser le membre traumatisé ;
3- Alerter les secours ou demander un avis médical ;
4- Respecter les recommandations données par les secours ;
5- Surveiller la victime en lui parlant régulièrement et le protéger du froid (éventuellement).
NB : Il y a 2 genres de fractures : fracture fermée et fracture ouverte.

C) Surveillance

Elle est appliquée après les soins d'urgence, le blessé installé en bonne position. Le secouriste surveille l'évolution et renouvelle régulièrement l'examen, il est attentif aux fonctions vitales : la conscience, la ventilation, l'hémorragie, mais aussi à la température de la victime.
NB : Ne surtout pas oublier de parler avec la victime pour le réconforter.

III/ Les 10 règles du secouriste

1- Alerter les secours ;
2- Agir efficacement et rapidement ;
3- Classer par ordre d'urgence ;
4- Tenir la victime à 37°
5- Observer attentivement
6- Ne pas déplacer continuellement la victime ;
7- Ne pas jouer au médecin ;
8- Cas de brulure ou de morsure ;
9- Rassurer la victime ;
10- Connaitre le PAS.

Xlle Dakar

IV/ Boîte à pharmacie

Il faut :
- Avoir une boîte résistante et légère ;
- Ordre et propreté dans la boîte ;
- Remplacer les médicaments périmés ;
- Boîte hors de la portée des enfants.

COMPOSITION :
Coton - épingle de sûreté - bande adhésive – alcool – sparadrap – mercurochrome – pansement adhésif – seringue – vitamines – thermomètre – permanganate – sérum anti venin – eau oxygénée – désinfectant nasal – aspirine – baume – pommade – ciseaux – lame de rasoir – eau bouillie refroidie.

V/ Quelques notions

ABC du secourisme= Allongement
Bouche à bouche
Comprimer les veines ou artères

PAS= Protéger Alerter Secourir
MCE= Massage Cardiaque Externe
RCP= Réanimation Cardio- Pulmonaire
LVA= Libération des Voies Aériennes
PLS= Position Latérale de Sécurité
CAT= Conduite A Tenir.

XIIe Dakar

Session Réalisée par : **ALEXIS BARNABE DIOP**
ACT XIIe DAKAR.
2013/2014

SOURCE :

- INSTRUCTION HOMMES DE TROUPE, du Groupement National des Sapeurs Pompiers ;
- Réforme psc1 (pour les rénovations dans le secourisme) ;

- Connaissances personnelles.

XIIe Dakar